Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeirinha

Rua Manatá, 690, sala 525 - Bairro: Jardim Colinas - CEP: 94940190 - Fone: (51) 309-83396 - Email: frcachoeir4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5006729-62.2022.8.21.0086/RS

REQUERENTE: MARIA EDUARDA LAIMER DE MENEZES
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER** ajuizada por **MARIA E. L. DE M.**, ao tempo do ajuizamento da ação representada pela genitora, em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e do **MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA**. Referiu ter sido diagnosticado com doenças de CID10 F84.0 – Autismo Grave e CID10 F71.1 – Retardo Mental, necessitando, com urgência, de tratamento com o medicamento ARISTAB (Aripiprazol), 10 mg, 3 comprimidos ao dia, sob pena de risco de hétero e autoagressão, risco de lesões e ferimentos e risco de desenvolvimento de problemas cardiovasculares. Aludiu que requerimento administrativo de fornecimento tinha sido indeferido. Informou que a família não dispunha de condições de arcar com o custo do tratamento. Aduziu que os medicamentos alternativos, inclusive fornecidos pelo SUS, não tiveram resposta satisfatória. Pediu o deferimento de tutela de urgência para determinar aos réus o fornecimento do medicamento, tornando a medida definitiva ao final, com a procedência da ação. Acostou documentos.

Foi deferida a tutela de urgência e determinada a citação (evento 3, DESPADEC1).

O Município contestou o feito (evento 14, CONT1). Arguiu em preliminar a ilegitimidade e a necessidade de observância do benefício de ordem na execução da tutela, concentrando eventuais bloqueios de verbas na conta do ente diretamente responsável, pois o Município de Cachoeirinha estava inserido na fase de Gestão de Atenção Básica, cabendo-lhe prestar apenas os procedimentos básicos. No mérito referiu a necessidade de demonstração, por perito de confiança do juízo, das moléstias alegadas. Aludiu que deveria ser fixado na sentença o grau de responsabilidade de cada um dos entes ou o grau de ressarcimento a ser realizado. Requereu o acolhimento das preliminares ou a improcedência dos pedidos. Acostou documentos.

O Estado apresentou contestação (evento 16, CONT1). Arguiu em preliminar a necessidade de inclusão da União no polo passivo, em razão do Tema 793 do STF, pois o medicamento postulado na inicial não era padronizado no Sistema Único de Saúde. Discorreu acerca da necessidade de observância dos critérios do Tema 106 do STJ. Pontuou que deveria ser afastada condenação de caráter indeterminado, que permitisse inclusão de outras prestações não postuladas na inicial. Afastou possibilidade de ressarcimento/reembolso de valores. Aludiu que, em caso de condenação, deveria ser feita referência à denominação comum brasileira. Acentuou que o receituário médico deveria ser atualizado a cada seis meses. Pontuou a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEP. Afastou possibilidade de aplicação de multa. Requereu a inclusão da União no polo passivo e a improcedência dos pedidos.

Houve réplica.

As partes não postularam a produção de provas (evento 39, PET1, evento 42, PET1 e Evento 43).

RELATEI. PASSO A DECIDIR.

O processo está apto para julgamento, pois as partes não postularam a produção de outras provas.

Busca a parte autora o fornecimento do medicamento ARISTAB (Aripiprazol) 10mg, três cápsulas ao dia.

A legitimidade passiva, tanto do Estado, quanto do Município resta caracterizada.

Ao julgar o conflitos de competência suscitados pelo Juízo da Infância e da Juventude de Cachoeirinha o STJ decidiu que o juízo estadual é competente.

Além disso, no RE 1366243 - Tema n.° 1234, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi deferido pedido incidental de tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) **nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo**; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado

sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário (grifei).

Portanto, afasto a preliminar arguida pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, deixando de determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo.

O dever do Estado e do Município de fornecer serviços de saúde está na Constituição Federal e, especialmente, na legislação infraconstitucional regulamentadora do seu fornecimento a pessoas carentes, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um sistema único (art. 198 da Constituição Federal) do qual fazem parte a União, os Estados e os Municípios, os quais são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de serviços de saúde.

É sólido o entendimento jurisprudencial reconhecendo a solidariedade entre os entes federados quanto ao direito à saúde, valendo recordar orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178/SE, assim ementado:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.*
>
> *O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.*
>
> *(Tribunal Pleno, RE nº 855.178 RG/SE, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão geral – Mérito, DJe-050, divulgação em 13.03.2015, publicação em 16.03.2015)*

Destaco, de outra banda, em razão do benefício de ordem invocado pelo Município, que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar o sistema unitário de saúde, não pode se sobrepor à solidariedade constitucional. Atende ela a critério de conveniência administrativa, implicando repartição interna de responsabilidades, mas nem por isso pode se sobrepor à definição da Lei Maior, levando à remessa de responsabilidade um para outro.

Precisamente acerca do dever de fornecimento do medicamento de que necessita a parte autora, tem-se que o texto constitucional preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196). Este direito é corolário da inviolabilidade do direito à vida. Assim, são "direitos e garantias fundamentais" estabelecidos no § 1º do art. 5º, da Carta Magna. Repiso que a saúde é um direito de todos e dever do Poder Público. Portanto, não há falar em normas meramente programáticas, até porque, à luz dos arts. 5º, § 1º, 6º e 196, de nossa Constituição Federal, o direito à saúde, como espécie dos direitos sociais, resta incluído entre os direitos e garantias fundamentais e, portanto, tem aplicação imediata.

Por sua vez, o art. 7º do ECA prevê que "a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência".

Nessa esteira também preceitua o art. 11, § 2º, do referido Diploma Legal que:

> *Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)*
>
> *[...]*
>
> *§ 2o Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)*

Trata-se, portanto, o dispositivo em comento de mais uma norma infraconstitucional em sintonia com a Carta Magna de 1988, a qual prevê o acesso gratuito de todas as crianças e adolescentes brasileiros aos serviços unificados de saúde pública.

Na esteira da decisão que deferiu a tutela de urgência, o laudo médico acostado aos autos demonstra que foram atendidos os requisitos estabelecidos pelo STJ por ocasião do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, representativo da controvérsia referente ao TEMA 106 do STJ.

Oportuno ainda referir que a profissional médica que assiste a autora, que detem as melhores condições de avaliar o estado de saúde da paciente e prescrever o medicamento mais pertinente à patologia apresentada, justificou o uso do medicamento para CID da autora, referindo que (evento 1, LAUDO13):

Dos medicamentos listados nas listas padronizadas do SUS ou dos Protocolos Cínicos para esse diagnóstico, a paciente já está em uso de Risperidona 5 mg/dia, sem controle adequado da agitação psicomotora. Tem apresentado aumento muito significativo de peso, atualmente com 108 Kg, efeito colateral da Risperidona.

Desta forma, venho, por meio deste, solicitar a aquisição da medicação Aripiprazol 10 mg, 3 comprimidos ao dia, indicado para os sintomas do paciente, mas oferecendo um perfil de efeitos cardiovasculares e metabólicos bem mais favorável do que a Risperidona, disponibilizada pelo SUS. Familiares não têm condições financeiras de comprar a medicação.

Caso não seja administrado o medicamento prescrito poderão ocorrer as seguintes consequências/riscos para a saúde do paciente: a paciente pode vir a apresentar comportamentos como agressão, automutilação e ataques graves de raiva e outros comportamentos disruptivos. Há também risco de desenvolver problemas metabólicos e cardiovasculares. Há urgência na aquisição da medicação para evitar as conseqüências adversas acima.

A condição de ser a parte autora pessoa necessitada também está satisfeita, pois assistida pela Defensoria Pública e diante dos documentos acostados.

Portanto, é dever dos entes públicos disponibilizar à parte autora o medicamento de que necessita. Nessa esteira:

> *APELAÇÕES CÍVEL. ECA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VIOLADOS. DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA. Tratamento não disponibilizado pelo SUS. A Constituição Federal é de clareza solar ao determinar que se trata de um dever do Estado lato sensu em garantir o direito à saúde a todos os cidadãos, porquanto elevou tal direito ao patamar de social e fundamental, já que se encontra intimamente ligado ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Inteligência dos artigos 1º, inciso III; 6º e 196 todos da Carta Magna. Contudo, é pacífico o entendimento de que o fornecimento de medicamentos não disponibilizados pelo SUS deve limitar-se aos casos em que restar comprovada a necessidade/imprescindibilidade do tratamento à manutenção da saúde do indivíduo, a impossibilidade de substituição dos medicamentos/tratamentos/equipamentos por algum disponibilizado pelo SUS, bem como a hipossuficiência da parte. Jurisprudência pacificada por julgamento de Repercussão Geral. Precedentes jurisprudenciais. No caso concreto, restou comprovada a necessidade da infante de realizar o tratamento postulado, bem como a hipossuficiência econômica da sua família. O fornecimento de tratamento mediante decisão judicial não fere os Princípios da Separação dos Poderes, Legalidade e da Isonomia, tendo em vista que apenas se está assegurando, nos casos concretos que lhe são submetidos, o cumprimento de norma constitucional violada por omissão da Administração, incerta no âmbito da legalidade e passível, assim, de controle jurisdicional. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70080414097, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 21-03-2019).*

Sendo a responsabilidade solidária, eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, na esteira do precedente abaixo:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE 400MG. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. CACON. LISTAS DO SUS. TEMA 106 DO STJ. COMPATIBILIDADE. 1. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 3. Para os pacientes portadores de neoplasias malignas todo o tratamento é realizado através de órgãos específicos, os Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, vinculados à União. Tal fato, todavia, não retira o dever dos entes públicos de atendimento à saúde. 4. A parte demandante, por meio de atestado médico, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento. 5. **O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que "eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles"**. 6. Preenchimento dos requisitos estipulados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), onde admitida a possibilidade do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, em caráter excepcional. [...] (Apelação Cível, Nº 70083996017, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 17-03-2020) (grifei).*

Tendo a parte autora ingressado com a demanda via Defensoria Pública, os honorários advocatícios não são devidos pelo Estado. Tal entendimento foi inclusive sumulado pelo STJ (Súmula 421: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença"). A amparar tal entendimento, segue julgado da superior instância:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA. O Estado não está obrigado a arcar com honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado – FADEP, devido ao instituto da confusão – artigo 381 do Código Civil –, porquanto as qualidades de credor e devedor se concentram na mesma pessoa. Inteligência da Súmula 421 do STJ. A ação rescisória, AR 1937 Agr., de relatoria do Min. Gilmar Mendes, de 30/06/2017, a qual representa julgamento isolado do STF, refere-se à Defensoria Pública da União e não do Estado, cujos efeitos da decisão restaram*

limitados às partes litigantes naquela demanda, uma vez que não foi atribuída repercussão geral ao referido julgado. APELAÇÃO DESPROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 50077478220198210035, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 07-07-2023)

O mesmo não ocorre em relação ao Município, pois é um ente federativo, autônomo em relação ao Estado. Assim, são devidos honorários advocatícios pelo Município ao FADEP.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para tornar definitiva a tutela de urgência, determinando que os réus forneçam, de forma solidária, à autora MARIA E. L. DE M. a medicação em tela (Aripiprazol 10 mg, três compromidos por dia - evento 1, RECEIT16), observando-se a denominação comum brasileira, enquanto perdurar a necessidade. A comprovação da necessidade deverá ser feita pela parte autora perante o réu, no prazo por ele definido, com a apresentação de prescrição médica atualizada.

Os entes públicos ficam isentos do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei 14634/2014). Condeno-os, porém, ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014), em iguais proporções, com a ressalva, ao Estado, da condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular nº 03/2014-CGJ).

Suportará o Município réu honorários advocatícios em favor do FADEP de R$400,00.

Sentença não sujeita a reexame necessário.[1]

Publicada e registrada. Partes e Ministério Público intimados eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por **ANDREA CASELGRANDI SILLA, Juíza de Direito**, em 1/8/2023, às 18:19:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10043244548v19** e o código CRC **b67f1b40**.

---

1. 1REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL.FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS,HOSPITALARES E AFINS. MATÉRIA DE DIREITO JULGADA PELO STF EM CARÁTERDE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA SENDIMENTADA NO ÂMBITO DESTACORTE. INCIDÊNCIA DA REGRA DE EXCEÇÃO À REVISÃO OBRIGATÓRIA DASENTENÇA PREVISTA NO § 4º DO ART. 496 DO CPC/2015. REMESSA NECESSÁRIANÃO CONHECIDA. (Reexame Necessário Nº 70081627085, Sétima Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 23/05/2019) ↩